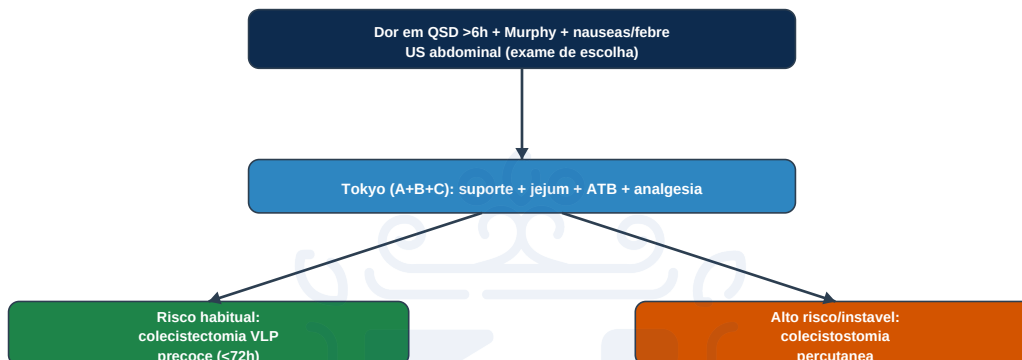


COLECISTITE AGUDA — TOKYO + COLECISTECTOMIA

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

COLECISTITE — MURPHY + US + GRAVIDADE (TOKYO)



DEFINIÇÃO E CLÍNICA

QUADRO TÍPICO

- Inflamação aguda da vesícula por obstrução do ducto cístico por cálculo -> distensão, isquemia, infecção secundária
- Dor CONTÍNUA em hipocôndrio direito/epigástrico > 6h, piora após alimentação gordurosa, náuseas/vômitos, febre (nem sempre)
- SINAL DE MURPHY positivo (dor à palpação do QSD em inspiração profunda); defesa localizada
- Idoso: quadro atípico, pouca dor e mais sepse — alta suspeição
- Dor + Murphy = pensar fortemente em colecistite

DIAGNÓSTICO (TOKYO GUIDELINES)

Critério	Achados
A — Local	Dor em QSD + Murphy positivo
B — Sistêmico	Febre, leucocitose (>12.000), PCR elevada
C — Imagem	US: cálculo no colo, parede > 3 mm, vesícula distendida, líquido pericolecístico, Murphy US+
Definitivo / Suspeita	A + B + C = definitivo; A + B = suspeita forte

EXAMES

LABORATÓRIO + IMAGEM

- Hemograma (leucocitose), PCR (gravidade), AST/ALT (ALT > 150 sugere origem biliar), FA/GGT (colestase), bilirrubinas (suspeita de coledocolitíase)
- Amilase/lipase (excluir pancreatite associada); função renal e lactato (gravidade/sepsse)
- US abdominal é o exame de ESCOLHA (sensibilidade ~85-90%): rápido e disponível
- TC se US inconclusivo ou suspeita de complicação (necrose, perfuração, abscesso, gás intramural = enfisematosa)
- Laboratório isolado não fecha diagnóstico — reforça

GRAVIDADE (TOKYO) DEFINE A CONDUTA

Grau	Critérios
I — Leve	Sem disfunção orgânica; inflamação local discreta
II — Moderada	Leucócitos > 18.000, sintomas > 72h, massa palpável, inflamação local importante
III — Grave	Disfunção orgânica: hipotensão, PaO ₂ /Fio ₂ < 300, creatinina elevada, rebaixamento

TRATAMENTO

Rx SUPORTE + ANALGESIA + ATB + CIRURGIA

Suporte: jejum, acesso venoso, hidratação com cristalóide, monitorização, correção eletrolítica
Analgesia: Dipirona 1 g EV 6/6h; Tramadol 50-100 mg 6-8/8h; Morfina 2-4 mg EV se dor intensa (opioides são seguros)
ATB leve: Ceftriaxona 1-2 g EV/dia + Metronidazol 500 mg EV 8/8h (ou Amox-clav 1,2 g EV 8/8h)
ATB moderada: Piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6h (ou Cefepime 2 g 12/12h + Metronidazol)
ATB grave/sepsse: Meropenem 1 g EV 8/8h (ou Imipenem); duração 4-7 dias (menor se fonte controlada)
DEFINITIVO: colecistectomia laparoscópica PRECOCE (ideal < 72h); colecistostomia percutânea se alto risco/instável

COMPLICAÇÕES / UTI

RECONHECER RÁPIDO

- Empiema, gangrena, perfuração da vesícula, peritonite biliar, sepsse
- Colecistite enfisematosa (gás intramural) — diabéticos, alta mortalidade
- Essas situações podem exigir cirurgia ABERTA de urgência
- UTI: choque, hipoxemia, IRA, lactato elevado, disfunção orgânica
- Suspeita de coledocolitíase associada (bilirrubina/FA altas, via dilatada) -> investigar/CPRE

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos com dor em QSD > 6h + Murphy +; febre ____; leucócitos ____; PCR ____.
- US: parede ____ mm, cálculo no colo ____, líquido pericolecístico ____; Tokyo grau ____.
- Condutas: jejum, hidratação, ATB ____ iniciado às ____, analgesia ____.
- Solicito cirurgia geral para colecistectomia precoce (ou colecistostomia se alto risco) / UTI se grau III.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Mulher de 45 anos, obesa, com dor contínua em hipocôndrio direito há 8h após refeição gordurosa, Murphy positivo, leucocitose. Qual o exame de escolha inicial?

- A) Tomografia de abdome com contraste
- B) Ultrassonografia abdominal
- C) Colangiorressonância (MRCP)
- D) CPRE diagnóstica
- E) Cintilografia hepatobiliar

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o tratamento definitivo de escolha na colecistite aguda de risco cirúrgico habitual?

- A) Antibiótico isolado por 6 semanas
- B) Colecistectomia laparoscópica precoce (ideal até 72h)
- C) Colecistostomia percutânea em todos
- D) CPRE com papilotomia
- E) Apenas dieta sem gordura

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Paciente idoso, alto risco cirúrgico, instável, com colecistite aguda grave. Qual a melhor opção de controle do foco?

- A) Colecistectomia aberta imediata
- B) Colecistostomia percutânea (ponte para cirurgia futura)
- C) Observação sem intervenção
- D) CPRE
- E) Apenas analgesia

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre a antibioticoterapia na colecistite aguda, é correto:

- A) Não se usa antibiótico em nenhum caso
- B) Indicada nos casos moderados/graves e nos leves se a cirurgia não for imediata, cobrindo Gram-negativos entéricos ($\pm$ anaeróbios)
- C) Sempre com carbapenêmico de início
- D) Apenas via oral em todos
- E) Por no mínimo 21 dias sempre

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual achado tomográfico indica colecistite enfisematosa?

- A) Espessamento de parede isolado
- B) Gás intramural na parede da vesícula
- C) Cálculo no colo
- D) Líquido pericolecístico
- E) Dilatação da via biliar

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A ultrassonografia abdominal é o exame de escolha na suspeita de colecistite (sensibilidade ~85-90%, rápida e disponível): mostra cálculo impactado no colo, parede > 3 mm, vesícula distendida, líquido pericolecístico e Murphy ultrassonográfico.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A colecistectomia laparoscópica precoce (idealmente até 72h) é o padrão-ouro, reduzindo complicações e recorrência. A colecistostomia percutânea fica para alto risco cirúrgico/instabilidade.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Em paciente de alto risco cirúrgico/instável, a colecistostomia percutânea drena a vesícula e serve de ponte para a colecistectomia futura, com menor morbidade que a cirurgia de urgência.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O ATB é indicado nos casos moderados/graves e nos leves quando a cirurgia não é imediata, cobrindo Gram-negativos entéricos e anaeróbios nos quadros mais graves; a escolha escalona conforme a gravidade.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O gás intramural na parede da vesícula caracteriza a colecistite enfisematosa, mais comum em diabéticos, com alto risco de gangrena/perfuração e elevada mortalidade — exige cirurgia urgente.

SM24
Suporte ao Plantão Médico